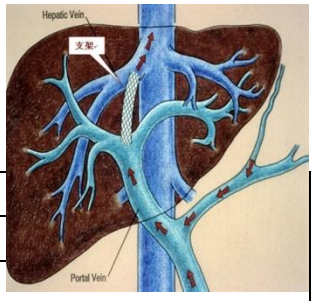
（4）一般治疗

①**限制水钠**摄入：入水量＜1000ml/d（伴低钠血症＜500ml/d），NaCl 摄入量＜2g/d　2X500=1000



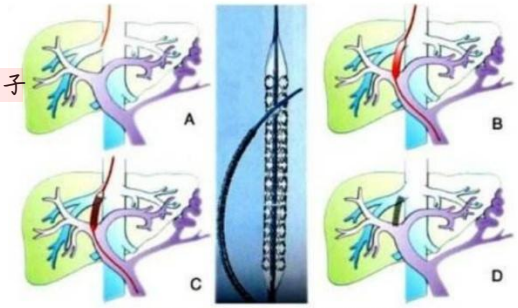
②利尿剂　肝脏对醛固酮灭活↓→继发性醛固酮增多

首选醛固酮受体拮抗剂螺内酯	与**呋塞米**按 100:40 联合使用
伴低钠血症者一般限水即可	否则可用血管加压素 V_2 受体拮抗剂**托伐普坦** 不排Na^+
利尿速度**不**宜过快（否则易发低钾低氯碱中毒）	以免诱发肝性脑病、肝肾综合征等
利尿效果不满意时	应酌情配合静脉输注**清蛋白**

TIPS大大降低门静脉压力→解决腹水、肝肾综合征、侧支循环…(肝性脑病的诱因↓↓)→减少了肝性脑病的发生

③经颈静脉肝内门腔分流术 **TIPS**：有效降低门脉压和增加肾血流

在门静脉分支和肝静脉之间放入支架→大大降低门静脉压力→减少腹水→有效循环血量↑→肾血流量↑　YYDS:TIPS、奥美拉唑、镜子



经颈静脉肝内门体分流术(TIPS)操作过程

（5）顽固性腹水若不能行 TIPS 可排放腹水

①放腹水易诱发肝性脑病、肝肾综合征等（姑息治疗）

②每放腹水 1L 输白蛋白 8g（一方有难八方支援）

③**腹水浓缩回输（但炎性腹水和癌性腹水禁止浓缩回输）**

肝纤指标：影像学:弹性成像；透明质酸、ⅢⅢⅠ型前胶原肽、Ⅳ型胶原、层粘连蛋白均↑(肝纤4项)　透明胶三四层

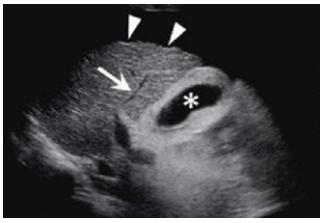
肝硬化的可能可能最可能：

中老年乙肝（HBsAg）、丙肝、酒精肝等病史，出现**脾大**（门脉高压最早）、**侧支循环**（门脉高压最特征）、**腹水/移动性浊音**（失代偿最突出）、**蜘蛛痣**、**黄疸**等

①首选 B 超：肝脏回声不均、形态失常如轮廓呈波浪样改变、门静脉主干增宽＞1.3cm

②诊断金标准：穿刺活检见**假小叶**　大量胶原纤维收缩




肝硬化临床表现

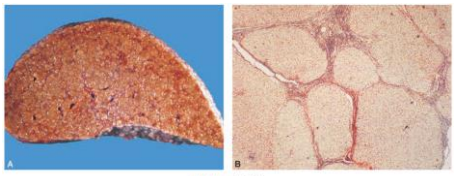
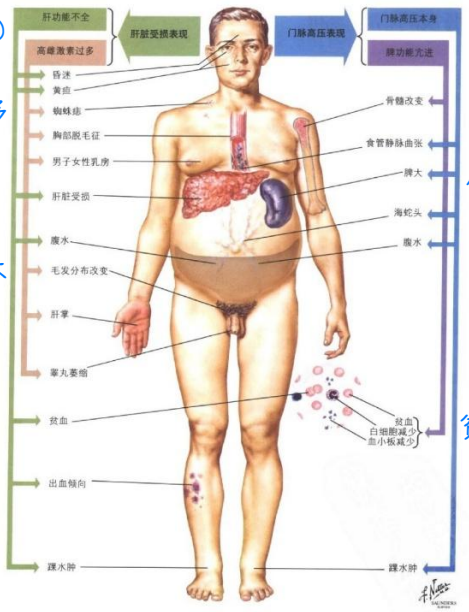


图 11-9　肝硬化
A. 表面和切面呈弥漫全肝的小结节；B. 弥漫全肝的假小叶形成，纤维组织分割原来的肝小叶并包绕成大小不等的圆形或类圆形的肝细胞团形成假小叶，假小叶内中央静脉常缺如。偏位（Van Gieson 染色）。



肝细胞性黄疸:血UCB↑,血CB↑(主)
尿胆红素(+)、尿胆素原不定

蜘蛛痣:雌激素灭活减弱,NO增多

腹水:2个门脉高压、2个肝功能不全、1个恶性循环

肝凝血因子合成↓

上消化道出血第二常见原因
脾大在代偿期就可以出现

贫血：脾亢破坏红细胞；长期出血